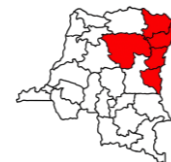




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°103/MVEBDB/25/08/2026

Date de rapportage : 25 août 2026

Date de publication : 26 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

En date du 25 août 2026, 57 nouveaux cas confirmés dont 11 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (34 cas), du Nord-Kivu (18 cas), Haut Uélé (5). Aucune nouvelle zone de santé touchée au cours de dernières 24h.

CUMUL DES CAS 5 713	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 744	LETALITE 48,0%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 770	CUMUL DES GUÉRIS 1 269	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 84,6 %
--	--	-------------------------------------	---	---	---



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



58 Zones de santé touchées sur 151

(38,4%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, **57 nouveaux cas confirmés** dont **11 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés dans les provinces de l'**Ituri (34 cas)**, **Nord-Kivu (18)**, **Haut Uélé (5)**.

En date du 25 août 2026, **24 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (20 en Ituri, 3 au Nord Kivu et 1 au Haut Uélé). D'autre part, **18 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 14 en Ituri, 2 au Nord Kivu et 2 au Haut Uélé.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 25 août 2026, **5 713 cas confirmés** dont **2 744 décès** ont été rapportés en RDC, soit une létalité de **48,0 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 83,1 % des cas confirmés cumulés et **59,6 %** des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures. Au total, 58 des 151 zones de santé des six provinces sont désormais affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (13/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Répartition des cas et décès confirmés par province touchée
(Au 25 août 2026)

Province	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées	Nouveaux cas confirmés(24h)
Ituri	4750	2 133	44,9%	28/36 (77,8 %)	34
Nord-Kivu	753	512	68,0%	13/34 (38,2 %)	18
Haut-Uélé	189	89	47,1%	6/13 (46,1 %)	5
Tshopo	15	8	53,3%	7/23 (30,4 %)	0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)	0
Bas Uélé	3	1	33,3%	3/11(27,3%)	0
Total	5 713	2 744	48,0%	58/151 (38,4 %)	57

Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 25 août 2026)

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4750	2133	44,9%	34	0	14	14
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	7	6	85,7%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	148	29	19,6%	9	0		0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1317	411	31,2%	5	0		0
Damas	27	9	33,3%				0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	73	30	41,1%				0
Gethy	5	2	40,0%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	61	39	63,9%				0
Lita	204	111	54,4%				0
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	19	4	21,1%	1	0		0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%	3	0		0
Mandima	32	19	59,4%				0
Mangala	203	109	53,7%				0
Mongbwalu	605	284	46,9%	2	0		0
Nia-Nia	199	108	54,3%	6	0		0
Nizi	628	252	40,1%	6	0		0

Nyankunde	124	35	28,2%	1	0		0
Rimba	10	4	40,0%				0
Rwampara	921	335	36,4%	1	0		0
Tchomia	55	25	45,5%				0
A ventiler	NA	280	NA	NA	NA	14	14
Nord-Kivu	753	512	68,0%	18	9	2	11
Beni	118	85	72,0%			1	1
Butembo	146	110	75,3%	6	3	0	3
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%	1	0	0	0
Katwa	360	241	66,9%	9	4	1	5
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	3	2	66,7%				0
Masereka	7	4	57,1%				0
Musienene	72	43	59,7%	2	2	0	2
Mutwanga	1	1	100,0%				0
Oicha	7	4	57,1%				0
Vuhovi	5	2	40,0%				0
Haut-Uélé	189	89	47,1%	5	2	2	4
Boma Mangbetu	26	14	53,8%			1	1
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	74	32	43,2%	4	1	1	2
Pawa	20	15	75,0%				0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	65	27	41,5%	1	1	0	1
Tshopo	15	8	53,3%	0	0	0	0
Bafwasende	1	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	6	4	66,7%				0
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	3	1	33,3%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				
Ganga	1	0	0,0%				
Total	5713	2744	48,0%	57	11	18	29

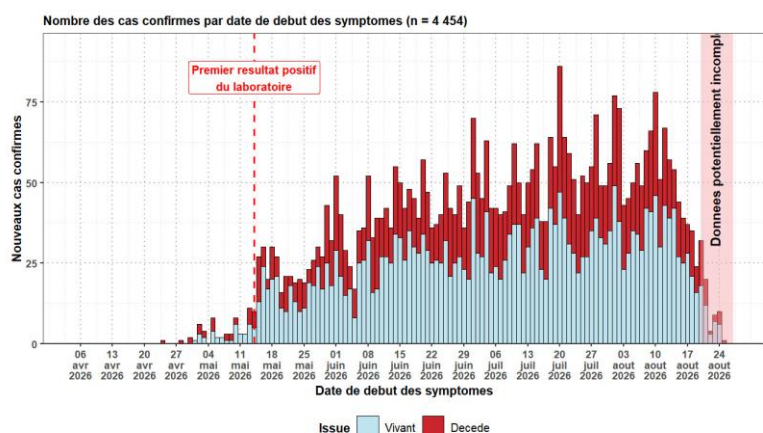
*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

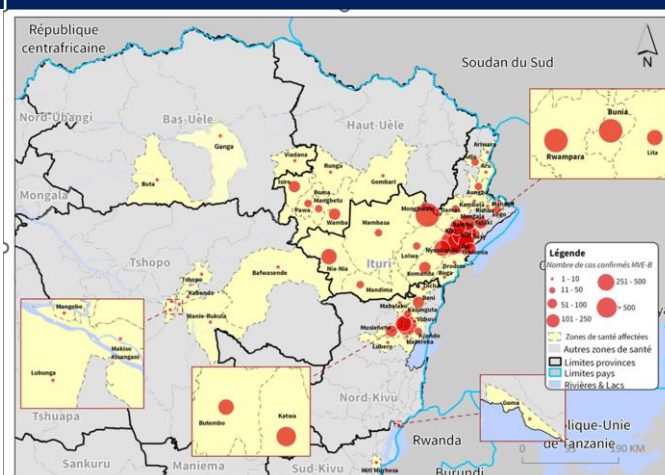
Situation des alertes notifiées par province, au 25 août 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bas Uélé	17	2	19	1	2	16	0	3	1
Ituri	840	70	910	164	65	484	0	229	129
Nord-Kivu	1 241	50	1291	95	50	1146	0	145	63
Sud-Kivu	13	0	13	6	0	7	0	6	6
Tshopo	137	1	138	7	0	130	1	7	5
Total Général	2248	123	2 371	273	117	1783	1	390	204

Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours



CARTOGRAPHIE DES CAS de 21 derniers jours



1. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1.Coordination

1.1.1. Principales Actions

- **Nord-Kivu** : tenue de la réunion de la coordination.
- **Ituri** : Poursuite de la supervision des activités de la riposte et tenue de la réunion de la coordination.
- **Tshopo** : Tenue de la réunion de la coordination et poursuite de la supervision des activités de la riposte.
- **Sud-Kivu** : Poursuite de l'intensification de la surveillance et de la recherche active dans les ZS d'Ibanda et de Nyangezi ; la province reste sans nouveau cas confirmé et le dernier remonte au 10 juin 2026.

1.1.2. Surveillance épidémiologique

1.1.3. Principales Actions

Au terme de la journée du 25 août 2026, 2 371 alertes ont été enregistrées, dont 2 174 (91,7%) ont été vérifiées dans les cinq provinces ayant transmis leurs données. À l'issue de ces vérifications, 390 (17,9 %) ont été validées comme cas suspects ; tous les 390 suspects ont été investigués, soit 100 %, parmi lesquels 204 ont été transférés vers les CT/CTE.

La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures se situe à 84,6 % (18 574 vus sur 21 959 à suivre), en dessous du seuil de 85 % : Ituri 87,3 % (11 276/12 912), Tshopo 100,0% (489/489) et Nord-Kivu 80,6 % (6 672/8 274) et Bas Uélé 48,2% (137/284) affichent des faibles taux de suivi (les données de la province du Haut Uélé n'ont pas été rapportées).

Au Bas-Uélé : poursuite des investigations et du suivi des contacts autour du cas confirmé de l'aire de santé d'Agri-Uélé (ZS de Ganga).

1.1.4. Défis

Faible suivi des contacts autour des cas confirmés principalement dans la province du Bas Uélé lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

- Cinq (5) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : trois en Ituri, dont deux alertes vivantes validées et transférées au CT/CTE (100 %) et un corps sans vie intercepté au PoC de Base Yedi (ZS Komanda), dont le swab s'est révélé positif ; deux au Nord-Kivu, il s'agit de deux corps sans vie interceptés au PoC de Kasitu (ZS Beni) et orientés à la morgue de l'HGR Beni pour swab et sécurisation. Aucune alerte n'a été notifiée au Haut-Uélé, au Bas-Uélé, à la Tshopo et au Sud-Kivu.

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	98,3 % (59/60)	100 % (18/18)	ND	71,4 % (5/7)	54,5 % (6/11)	35,0 % (7/20)	81,9 % (95/116)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)	100 %	NA	35 %	55 % (6/11)	ND	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	138 871	83 918	84 432	8 561	8 167	ND	323 949
% des voyageurs screenés	97,0 %	97,89 %	100 %	99,3 %	100 %	100 %	98,1 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	96,8 %	97,89 %	100 %	99,1 %	100 %	100 %	98,1 %
% des voyageurs sensibilisés	99,4 %	97,89 %	100 %	100 %	99,6 %	ND	99,2 %
Nombre d'alertes notifiées	3	2	0	0	0	0	5
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	2	0	0	0	0	0	2

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	2	0	0	0	0	3
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100 % (2/2)	NA	0 %	0 %	0 %	0 %	100 % (2/2)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100 % (1/1)	0 % (0/2)	0 %	0 %	0 %	0 %	33,3 % (1/3)
% des cas suspects investigués dans 24 h	100 % (2/2)	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 % (2/2)

1.2.2. Défis

Opérationnalisation insuffisante des PoE/PoC : la complétude nationale se situe à 81,9 % (95 rapports sur 116), avec des niveaux faibles au Bas-Uélé (35,0 %) et au Haut-Uélé (54,5 %). En Ituri, 1 (9,1 %) des 11 PoE/PoC stratégiques fonctionne sans interruption ; au Haut-Uélé, cinq PoC (Dusu, Apodo, Aungba, PK6 Niangara et Gossamu) n'ont pas fonctionné pour cause de grève des prestataires non rémunérés ; la Tshopo présente une complétude partielle du rapportage (5/7 PoE/PoC). Au Sud-Kivu et au Haut-Uélé, la démotivation des acteurs liée au non-paiement persiste et a entraîné l'arrêt de cinq PoC au Haut-Uélé.

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- **Ituri : 34 nouveaux résultats positifs** (34 vivants et 0 décès) sur 231 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 14,7 %**).
- **Nord-Kivu : 18 nouveaux résultats positifs** (9 vivants et 9 décès) sur 178 échantillons analysés (**positivité de 10,1 %**).
- **Haut-Uélé : 5 nouveaux résultats positifs** (3 vivants et 2 décès) sur 18 échantillons analysés (**positivité de 27,8 %**).
- **Bas-Uélé : aucun nouveau résultat positif sur 3 échantillons analysés (positivité 0 %).**

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 21 rings ont été ouverts sur les 101 identifiés (20,8 %), 165 ménages décontaminés sur 173 identifiés (95,3 %) et 11 FOSA sur 11 (100 %) ; 6 évaluations de FOSA ont été réalisées et 17 kits PCI ont été dotés aux ménages. Le pilier EDS a reçu 86 alertes (10 reports) : 71 corps swabés et 82 EDS réalisés.
- **Au Nord-Kivu**, le pilier EDS a reçu 37 alertes (15 reports) : 36 corps swabés, un échec de swab (refus du sac mortuaire à Kalunguta) et 34 EDS réalisés.
- **Au Bas-Uélé**, 3 rings ont été ouverts (Buta, Viadana et Ganga), 2 ménages décontaminés à Ganga et l'HGR de Buta a été évalué (score card de 54,3 %). Deux alertes de décès ont été reçues et 2 corps swabés.
- **À la Tshopo**, 10 ESS ont été accompagnés dans 3 zones de santé (Makiso-Kisangani, Mangobo et Tshopo), où 106 prestataires ont été briefés ; suivi de la fonctionnalité de 10

dispositifs de lavage des mains et 10 unités de triage installées ; la formation de 35 hygiénistes (5 équipes) de 4 zones de santé a été réalisée.

1.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings reste limitée à 20,8 % et des échecs de swab ont été enregistrés ; un membre de l'équipe EDS est décédé dans un accident de circulation (ZS Bambu) et deux autres ont été agressés à Rwampara (AS Makabo).
- Au Bas-Uélé, la décontamination du ménage des proches du premier cas confirmé de Buta n'a toujours pas pu être réalisée en raison d'une résistance communautaire continue, le pré-rupture de plusieurs intrants PCI retardant le briefing des prestataires des ZS.

1.5. Continuité des soins

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 88 nouvelles admissions ont été enregistrées et 97 sorties dont 20 guéris. Ainsi, 488 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation global de 49,9 %.
- **Au Nord-Kivu**, 53 admissions ont été enregistrées contre 37 sorties dont 1 guéri. Au terme de la journée, 194 patients sont hospitalisés pour 206 lits, soit un taux d'occupation global de 94,2 %.
- **À la Tshopo**, 3 nouvelles admissions de cas suspects et 8 patients isolés pour 14 lits, soit 57,1% d'occupation
- **Au Bas Uélé**, 1 cas confirmé est en isolement à l'HGR Ganga.
- **Au Haut Uélé**, 9 admissions ont été enregistrées contre 6 sorties, dont 3 guéris. Un total de 79 patients sont en isolement pour 120 lits, soit 65,8% de taux d'occupation.

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et absence des CTE dans certaines zones de santé ; saturation des CTE de Bambu (confirmés) et de Kilo (suspects) en Ituri et dépassement de la capacité en lits suspects au Nord-Kivu (163 patients pour 142 lits) et au Haut-Uélé (CTE Wamba en sursaturation chez les lits suspects).

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 335 contacts ont été listés autour des cas confirmés (211 à Rwampara et 124 à Lolwa) ; 267 personnes ont été sensibilisées en communauté et 43 inspecteurs scolaires, dont 8 femmes, formés à Bunia
- **À la Tshopo**, 1 116 personnes ont été sensibilisées lors de visites à domicile dans 186 ménages de Makiso, Mangobo et Kabondo ; 3 émissions ont été animées et des spots diffusés sur 6 chaînes de radio et de télévision, 61 leaders confessionnels (52 hommes et 9 femmes) ont été sensibilisés et une rumeur a été clarifiée.
- **Au Nord-Kivu**, 44 personnes ont été touchées autour des cas confirmés dans les aires de santé de Madrandele (40, dont 8 prestataires) et de Mabolio (4) ; les données sur les rumeurs clarifiées et les sensibilisations de masse ne sont pas disponibles pour la journée.
- **Au Haut-Uélé**, 14 kits PCI ont été dotés aux ESS, 8 évaluations et 11 accompagnements d'ESS réalisés et 55 prestataires briefés ; 7 rings ont été ouverts (Wamba 4 et Pawa 3), 6

ménages et 3 ESS décontaminés. Le pilier EDS a reçu 7 alertes, 7 corps ont été swabés sans échec et 5 EDS réalisés.

- **Au Bas-Uélé**, Poursuite de la sensibilisation à la MVE, aux mesures de prévention et à l'enterrement digne et sécurisé a été organisée auprès du groupe des jeunes de l'avenue Mobenge à Buta, assortie de la remise d'un dispositif de lavage des mains.

1.6.2. Défis

Persistance de défis au niveau communautaires : en Ituri, des refus de prélèvement (Nia-Nia), de swab (Alimasi) et de listage des contacts (Kilo État). Au Haut-Uélé, les équipes de riposte ont été agressées à Isiro et à Pawa.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 25 nouveaux cas confirmés couverts et 107 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 34 nouveaux suspects et 119 suspects en cours de suivi ; 51 ménages ont été accompagnés, 15 PPL soutenus, 60 enfants sui-vis en communauté et 70 annonces de résultats réalisées, dont 25 positives. Douze guéris sur 20 (60 %) ont été réinsérés.
- **Au Nord-Kivu**, 11 des 18 nouveaux cas confirmés (61,1 %) et la totalité des 57 nouveaux cas suspects (100 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 68 annonces de résultats ont été réalisées, dont 11 positives, 72 PPL accompagnés et 22 enfants séparés ou orphelins suivis en communauté.
- **Au Haut-Uélé**, 1 nouveau cas confirmé et 22 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'un appui psychosocial, ainsi que 3 nouveaux suspects, 33 accompagnants et 15 PPL ; 17 annonces de résultats ont été faites, dont 2 positives.
- **À la Tshopo**, 4 nouveaux cas suspects et 4 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'un entretien et d'un soutien psychologique, ainsi qu'un accompagnant de cas hospitalisé ; 4 résultats de laboratoire ont été annoncés, dont aucun positif, et 27 contacts ont bénéficié d'un soutien psychologique.

1.7.2. Défis

Au Haut Uélé, la couverture reste limitée à 2 des 6 zones de santé affectées (33,3 %), à cause du nombre insuffisant d'agents psychosociaux.

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

- Poursuite de la mise à disposition de la mobilité des acteurs du terrain dans les différentes provinces et livraison des intrants PCI dans les zones de santés touchées.

1.9. Sécurité

1.9.1. Principales actions

- Appui aux équipes déployées dans les différents axes en réalisant le monitoring sécuritaire dans les zones de santé d'accès difficile.

1.9.2. Défis

La sécurisation des PoC stratégiques reste incomplète : un corps sans vie intercepté au PoC de Mangina (ZS Komanda) n'a pu être swabé pour raisons d'insécurité.

1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.10.1. Principales actions

Poursuite d'appui à une formation des leaders communautaires, militaires et policiers sur la PSEA et la MVE, conjointement avec le pilier communication.

1.10.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA, limitée à 4 zones de santé sur 36 en Ituri, absence de cartographie des intervenants, insuffisance de supports de sensibilisation de masse et manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier ; La couverture demeure limitée à 4 des 36 zones de santé de l'Ituri (11,1 %) et seuls deux partenaires (OMS et Africa CDC) rapportent leurs activités PSEA.

MESSAGES CLES

- La transmission de la MVE reste active, avec 57 nouveaux cas dont 11 décès communautaires et 18 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 5 656 cas confirmés et 2 715 décès.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 83,1 % des cas confirmés cumulés et 59,6% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 ZS affectées).
- La surveillance affiche une bonne performance (100,0%) des cas suspects investigués tandis que le taux de suivi (84,6%) proche du seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd